

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGATURAN POSISI (<i>POSITIONING</i>) NEONATUS		
	No.Dokumen 922.4/I-SPO/NICU/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	Tindakan mengatur posisi tubuh bayi baru lahir (neonatus) secara terapeutik untuk mendukung kenyamanan, stabilitas fisiologis, dan perkembangan optimal.		
Tujuan	1. Mendorong fleksi fisiologis (posisi meringkuk alami) 2. Meningkatkan kualitas tidur dan konservasi energi 3. Menjaga patensi jalan napas dan optimalisasi fungsi paru 4. Mencegah deformitas tulang tengkorak (<i>plagiocephaly</i>) dan sendi 5. Memfasilitasi perilaku menenangkan diri (<i>self-soothing</i>)		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Panduan Penyelenggaraan PONEK 24 jam		
Prosedur	A. Persiapan Alat 1. <i>Nesting</i> (sarang buatan) yang sesuai ukuran bayi 2. Gulungan kain atau handuk kecil (sebagai penyangga) 3. Empeng 4. HandRub B. Prosedur Pelaksanaan 1. Cuci tangan sesuai prosedur WHO sebelum menyentuh bayi 2. Lakukan tindakan dengan prinsip Minimal Handling (gabungkan dengan jadwal pemberian nutrisi atau observasi tanda vital) 3. Waktu perubahan positioning a. < 28 minggu : setiap 6-8 jam b. Bayi sakit berat : setiap 8- 12 jam c. Pemberian minum bayi setiap 2 jam : setiap 4 jam d. Pemberian minum bayi setiap 3jam : setiap 3 jam 4. Gunakan <i>nesting</i> untuk memberikan batas (sensasi seperti di dalam rahim) 5. Macam-Macam Posisi a. Posisi Terlentang (<i>Supine</i>): 1. Lakukan kebersihan tangan 2. Hangatkan dua telapak tangan 3. Pertahankan kepala bayi di garis tengah dan tidak menoleh ke satu sisi. Berikan bantalan halus di leher		

- untuk membantu menopang posisi kepala
- 4. Posisi kepala sedikit fleksi dengan dagu mendekati dada
- 5. Topang bahu dengan kain hingga posisi bahu sedikit fleksi kearah dada
- 6. Abduksikan kedua tangan sehingga ujung tangan berada didekat mulut bayi
- 7. Posisikan pinggul dan lutut fleksi
- 8. Lutut berada di garis tengah sumbu tubuh dan posisi lutut tidak terbuka keluar (posisi supine B)
- 9. Posisikan nest untuk dapat menjadi penopang kaki membentuk posisi fleksi dan menyilang
- 10.Rapatkan nest pada bagian terluar tubuh bayi sehingga tampak bayi terkurung dalam sangkar
- 11.Bentangkan kain halus untuk menutupi dada hingga kaki bayi dengan posisi kain menyilang sumbu tubuh

b. Posisi Tengkurap (*Prone*):

- 1. Lakukan kebersihan tangan
- 2. Hangatkan kedua telapak tangan
- 3. Saat membalik posisi dari supinasi ke pronasi, tetap pertahankan posisi supinasi dengan cara memegang tangan dan kaki bayi selama proses peralihan posisi
- 4. Hadapkan kepala pada salah satu sisi dan ubah posisi kepala secara rutin untuk mencegah deformitas kepala
- 5. Pinggul dan lutut difleksikan sehingga membentuk posisi kaki katak
- 6. Pastikan posisi pinggul lurus dengan sumbu tubuh dan tidak miring kesalah satu posisi
- 7. Posisikan tangan dan kaki dibawah tubuh bayi dengan posisi ujung tangan menuju kemuka
- 8. Berikan bantalan lembut dan tipis dibawah sternum dan perut untuk mensuport dada bayi bernafas dan mencegah retraksi bahu
- 9. Rapatkan nest sehingga dapat menopang dan mempertahankan bentuk posisi yang dijelaskan di atas
- 10.Pemberian posisi ini harus di iringi dengan pemasangan monitor kardio-respiratori untuk memantau status oksigenasi

c. Posisi Quarter Prone

- 1. Siapkan linen/ kain panel sebanyak 2 buah
- 2. Gulung masing-masing kedua kain menjadi kecil
- 3. Hangatkan kedua tangan sebelum menyentuh tubuh bayi
- 4. Letakan kain 1 yang sudah di gulung pada bagian satu sisi bayi
- 5. Posisikan bayi miring kanan atau kiri (sesuaikan kebutuhan bayi)
- 6. Posisikan sisi Bagian kepala diatas gulungan kain, secara berbarengan posisikan tangan dan kaki kanan atau kiri seperti memeluk guling namun posisi hampir seperti prone (tengkurap)
- 7. Perhatikan tangan bayi fleksi dan sedekat mungkin

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGATURAN POSISI (<i>POSITIONING</i>) NEONATUS		
	No.Dokumen 922.4/I-SPO/NICU/X/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3
	dengan mulut dan kaki sedekat mungkin dekat dengan perut 8. Berikan kain ke 2 yang sudah digulung melingkari bagian kaki dengan membentuk "U" d. Posisi Side Lying 1. Posisikan bayi lateral kanan ataupun kiri (sesuai indikasi) 2. Pertahankan kepala agar tetap lurus dengan cara memberikan bantalan disepanjang kepala, tulang belakang (mengikuti sumbu tubuh), hingga melingkar kedepan dada Posisikan kedua tangan memeluk bantalan tersebut 3. Fleksikan lutut 4. Pasang nest dengan rapat sehingga dapat menopang dan mempertahankan bentuk posisi yang dijelaskan di atas 5. Posisikan bayi lateral kanan ataupun kiri (sesuai indikasi) C. Pemantauan & Evaluasi 1. Ubah posisi bayi setiap 2–4 jam (atau sesuai toleransi bayi) untuk mencegah luka tekan 2. Pastikan kepala bayi berganti sisi (kiri/kanan) untuk mencegah kepala peyang 3. Pastikan jalan napas tidak tertekuk dan saturasi oksigen stabil setelah perubahan posisi. 4. Pantau tanda-tanda stres (mnangis, perubahan warna kulit, atau jari meregang) D. Dokumentasi Catat waktu perubahan posisi, jenis posisi yang diberikan, dan respons toleransi bayi dalam catatan terintegrasi		
Unit Terkait	1. <i>Neonatal Intensive Care Unit (NICU)</i> 2. <i>Pediatric Intensive Care unit (PICU)</i> 3. Perinatologi		